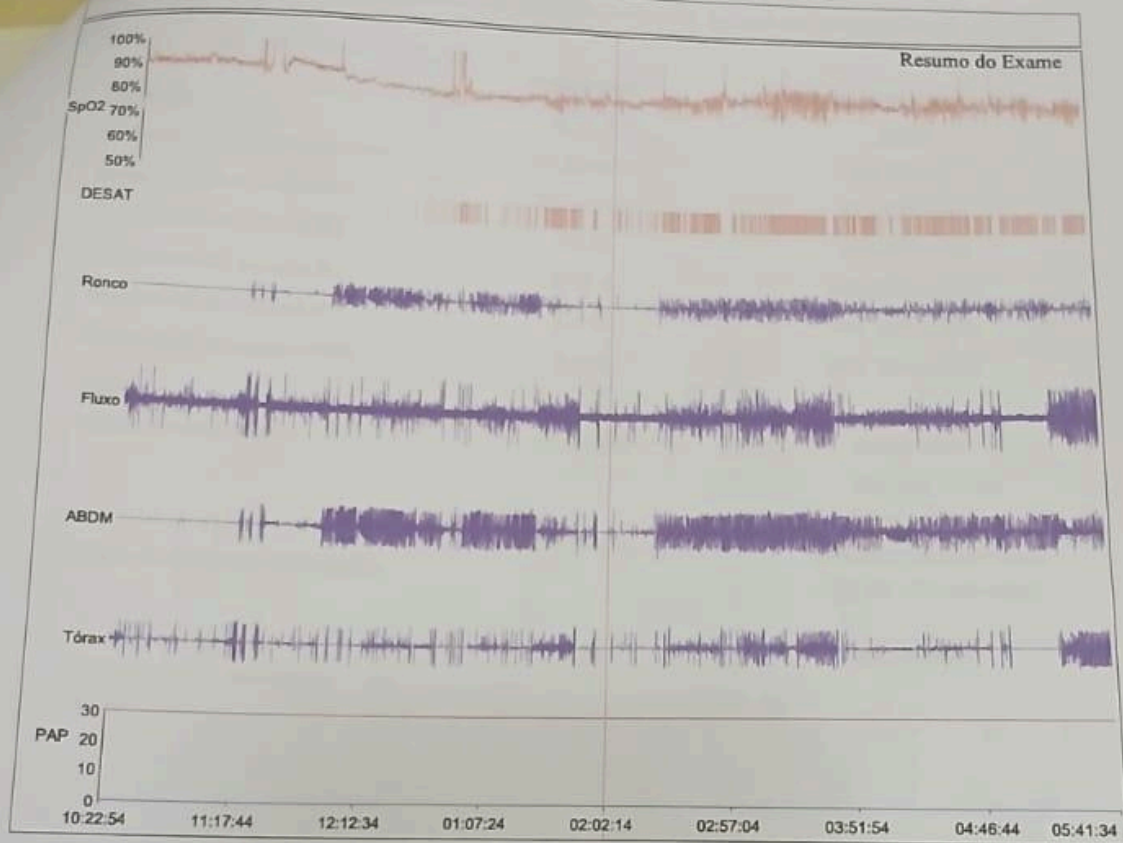
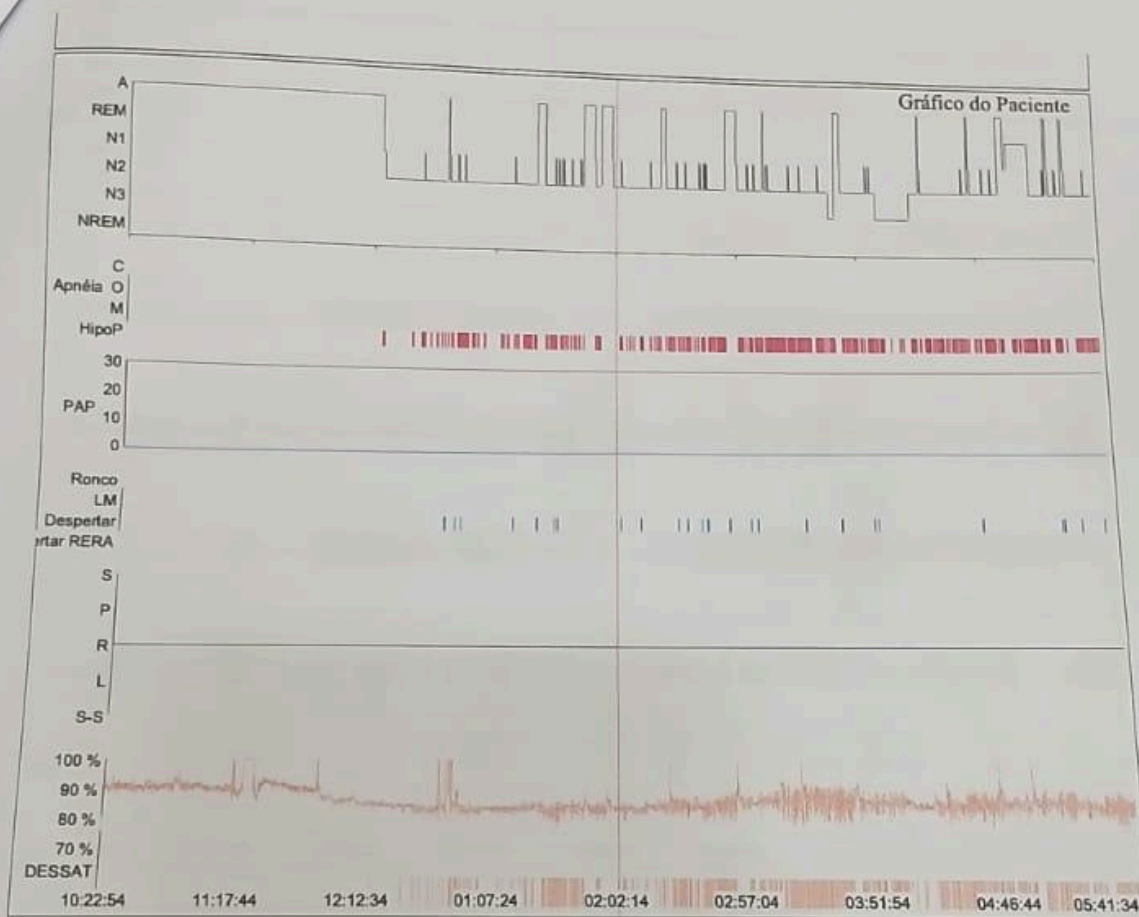


Parâmetros de normalidade recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (versão 3.0/2022)

	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	67,2 %	≥85%
Latência para o início do sono	113,0 min	até 30 min.
Latência para o sono REM	287,0 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	7,8 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	82,6 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	6,1 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	3,4 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	32,8 %	5%
Índice de despertares	6,8 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	59,0 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h



RESUMOS GRÁFICOS:



DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	84%	77%
NREM:	84%	77%
REM:	86%	81%
Vigília:	88%	79%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 84%

Total de dessaturações: 387

"PLMS" (Periodic limb movements in sleep)		
Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/

POSIÇÃO DE OCORRÊNCIAS DAS APNEIAS:

	REM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	0	0
DIREITO	0	0	0	12	0
ESQUERDO	0	0	0	0	0
SUPINO	0	0	0	0	0
	NREM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	0	0
DIREITO	0	0	0	276	0
ESQUERDO	0	0	0	0	0
SUPINO	0	0	0	0	0

IDADE: 53
AUTOMAS

Despertares			
		Número	Índice (nº/h)
Total despertares	de	50	6,8

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	62,1	68
NREM	67,3	80
Vigília	68,9	79

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	0	0	0	288	288	0	288
Índice	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0	0,0	59,0
Índice em REM	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	72,0	0,0	72,0
Índice em NREM	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	58,5	0,0	58,5
Duração máx (seg)	0	0	0	0	79,9	79,9	0	79,9
Duração média (seg)	0	0	0	0,0	22,5	22,5	0	22,5
Índice em Supino	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice em o Supino	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0	0,0	59,0

Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;

Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;

RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 59,0 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 59,0 (nº/h)

DADOS DO PACIENTE:

Nome: DANILO MARINO MAGRINE
ID: 0
Altura: 1,70 m
Peso: 110 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 14-6-1978
IMC: 38,06

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 22:22:54
Data do Exame: 17-02-2026
Médico Solicitante: DRA. NATALIA T. SOUZA

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	17/02/2026 22:22
Data/Horário de Término:	18/02/2026 05:41
Tempo Total de Registro (TTR):	435,7
Tempo Total de Sono (TTS):	293,0
Latência para o início do sono:	113,0
Latência para o sono REM:	287,0
Tempo acordado após o adormecer:	29,7
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	67,2 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	23,0	242,0	18,0	10,0	143,0
% de TTS	7,8	82,6	6,1	3,4	32,8

IDADE: 53
TOMAS:

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: DANILO MARINO MAGRINE
Data do Exame: 17-02-2026
Peso: 110 kg
Médico Solicitante: DRA. NATALIA T. SOUZA

Sexo: Masculino
Idade: 47 anos
Altura: 1,70 m

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 17/02/2026 22:22 e finalizado às 18/02/2026 05:41.
A latência para início do sono foi de **113,0 min** e a latência para o sono REM de **287,0 min**.
O tempo total de sono (TTS) foi de 293,0 min, com eficiência do sono de **67,2 %**.
A distribuição dos estágios do sono mostrou **7,8 %** de estágio N1, **82,6 %** de estágio N2, **6,1 %** de estágio N3 e **3,4 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 29,7 min. Ocorreram 50 despertares, sendo o índice de **6,8 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 288, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 288 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **59,0 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 72,0 e o IDR durante o sono NREM foi de 58,5. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 59,0 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 59,0 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 88%, a média de 84% e a mínima de 77%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 52,9 (nº/h), sendo que em REM foi de 102,0 (nº/h) e em NREM foi de 78,2 (nº/h). Permaneceu 79,9 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (09), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:
Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**59,0 nº/h**) (VN= até 5 nº/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**77%**);
3. Latência para o início do sono (**113,0 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**287,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**67,2 %**) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares **6,8 nº/h** (VN= até 15 nº/h);
7. Percentual do estágio N1 (**7,8 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**82,6 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**6,1 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**3,4 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando índice de distúrbio respiratório de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono